



47-83 Boulevard de l'Hôpital
75013 Paris

Standard : 01 42 16 00 00

Monsieur CA Test

Not specified

DMU DEMIURGE

PARIS CEDEX 13, le 24/04/2026

Service des Urgences
Pr Yonathan FREUND

Tél accueil. 01 42 17 72 47

Références : JKH

Secrétariat médical :
Tél. 01 42 17 72 42
Tél. 01 42 17 72 68
Fax. 01 42 17 70 10

Compte-rendu de passage aux Urgences

MCU - PH
Dr A. L. PHILIPPON

Entrée le : 24/04/2026 00:00

Nom JF : CA

Praticiens Hospitaliers :
Dr A. AUBRY
Dr P. CANAVAGGIO
Dr M. CANCELLA de ABREU
Dr C. CASSARD
Dr S. DELERME
Dr M. DUMONT
Dr V. DUNOYER
Dr G. ERNOTTE
Dr T. KAHLHOVEN
Dr L. LANDAU
Dr J. PERNET
Dr M-C. RICHARD
Dr K. SAIDI
Dr N. SALHI
Dr L. VELLI

Nom : CA

Prénom : Test

IPP : 40

Né(e) le : 16/07/2010 (15 ans)

Sexe : M

Adresse : Not specified

Téléphone : Not specified

Email : Not specified

PH Contractuels - Assistants :
Dr S. BEKHIT
Dr S. BESCH
Dr J. BIHET
Dr G. BILLAUD
Dr O. CHARAI
Dr O. DENIS
Dr A. EID
Dr F. GIRET
Dr A. GUEZ
Dr A. HASSAN
Dr S. LEE
Dr T. RICHARDEAU
Dr T. SALA
Dr A. SALLENBRE
Dr A. VROMANT
Dr S. QUEDEC

Prise en charge / Nom de l'accueil:

22/07/2025 09:48

Score de tri : Score 2

Motif de tri : Douleur thoracique / syndrome coronaire

Paramètres vitaux, à l'accueil :

PA : 117/64 mmHg Dextro : 5.1 mmol/L FC : 64 /mn Temp : 36.6 °C
SpO2 : 99 % EVA : 0 Hb Cap : 12.9 g/dL
GCS : 15 (Y:4 / V:5 / M:6)

Paramètres vitaux, dernière prise :

TA : 104/59 mmHg Temp : 36.4 °C FR : 12 /min SpO2 : 100 % Hb
Cap : 12.9 g/dL EVA : 0 CGS : 15 (Y:4 / V:5 /

Chefs de Clinique-Assistants :
Dr M. AWAD
Dr H. BANNELIER
Dr L. MATHON

Cadre Supérieure de Santé :
N. HADDADI-TAIBI
Tél. 01 84 82 73 19

Cadres de Santé :
Tél. 01 42 17 72 48
Fax. 01 42 17 75 30

Assistances Sociales :
Tél. 01 42 17 72 59 - (SAU)
Tél. 01 42 17 72 79 - (UHCD)
Fax. 01 42 17 72 80

Pour récupérer vos imageries médicales,
Merci d'écrire à l'adresse :
radiologie.oncologique-cd@aphp.fr

Troponine Ic (Hs) : 3.0 ng/LD-Dimères : 175 ng/mL CRP : <5.0 mg/L CK : 93 U/L pH : 7.39 pCO2 :
45.0 mm Hg pO2 : 96 mm Hg Bicarbonate : 27.1 mmol/L Lactates : 0.4 mmol/L SatO2 : 98.0
% Sodium : 142 mmol/L Potassium : 3.8 mmol/L Créatinine : 62 umol/L Calcium ionisé : 1.24
mmol/L Ethanol : <0.1 g/L Leucocytes : 7.48 x10⁹/L Hématies : 6.08 x10¹²/L Hémoglobine : 12.9
g/dL Hématocrite : 40.2 % VGM : 66.1 fL TCMH : 21.2 pg CCMH : 32.1 g/dL Plaquettes : 271 x10⁹/L

Pat.: Test CA | M | 16/07/2010 | 40

Imprimé le 24/04/2026 00:00

CR URGENCES PSL ACCUEIL URGENCE (UF)

Antécédents

Allergies:

- B-ULTRAVIST (produit de contraste) : choc anaphylactique, oedème de Quincke- Zythromax : oedème de Quincke

Antécédents médicaux :

Traitements habituels

- Perindopril 8 mg : 1-0-1- Depuis le 20/07 Gabapentine 10 mg : 1-0-1- VNI 24/24 mais en pratique ne la met que la nuit

Mode de vie

Loge chez une amie infirmière à Brie-Comte-Robert dans le 77, Rebecca, rencontrée sur un site de lecture selon cette amie. Petite amie vivant à Rennes. Mère habitant dans le Sud, vue rarement. Plus de contact avec le père. MDPH, touche l'AAH. Ne travaille pas actuellement, était à son propre compte dans l'audiovisuel. Pas d'intoxication alcool-tabagique. Pas de drogue. Suivi à Rennes.

Anamnèse

Patient avec maladie de Neuhauser avec compression trachéale 50-70% et oesophagienne, myélopathie cervicale avec dysfonction diaphragmatique et hypoventilation alvéolaire appareillé par VNI 24/24. Suivi à Rennes. Malaises à répétition avec perte de connaissance, étiquetés d'origine probablement psychogène. Le patient dit avoir vu un psychiatre qui aurait écarté l'origine psychogène. Venu à Paris pour suite de la prise en charge médicale. Souhaite être mis en relation avec le centre des maladies rares à Pompidou. Passage aux urgences le 16/07 pour malaise, faiblesse musculaire et chutes à répétition. Légères fuites urinaires, pas d'incontinence fécale. Pas de fièvre. ECG rassurant. Biologie sans anomalie rapportée. IRM médullaire aux urgences sans anomalie. Retour à domicile et suite de prise en charge par médecins référents. Passage aux urgences PSL le 22/07 à 4h du matin pour sensation de récurrence de malaise sans malaise, dysgueusie avec goût de dissolvant dans la bouche, déjà présente lors des précédents malaises. Examen clinique et ECG rassurants. Pas de crise après 2 heures de surveillance. Pas de dyspnée. Conduite à tenir proposée : prendre rendez-vous à l'UCASAR en semaine entre 9h et 14h pour initier un suivi cardiologique dans un contexte d'HTA mal équilibrée et de malformation aortique rare opérée ; reprendre le bilan pour exploration neuropathie au CHU Rennes ou récupérer le dossier pour transfert ; retour à domicile. Appel du SMUR car retrouvé dans la rue par des passants allongé sur un banc en face de PSL, inconscient. A l'arrivée du SMUR : Glasgow 3, dextro normal, température 36,6°C, stable sur le plan hémodynamique et respiratoire. Puis récupération progressive de la conscience spontanée, redevenu Glasgow 14. Un épisode de vomissement alimentaire selon le patient. Amené aux urgences PSL pour poursuite de la prise en charge. Selon l'amie Rebecca jointe par téléphone : le patient lui aurait dit ne pas se sentir bien le 22/07 à 1h du matin, avec impression qu'il allait faire un malaise. A décidé de se rendre seul aux urgences de PSL en bus de nuit. Rebecca l'aurait accompagné à la station de bus puis il se serait rendu seul à Paris. Dernier contact avec la mère en mai 2025. Les malaises seraient toujours similaires : sensation de perdre connaissance, dysgueusie, pas de dyspnée.

Examen clinique initial

Constantes : PA 117/64 mmHg, FC 64/min, saturation 99% en air ambiant, FR 18/min, température 36,6°C, dextro 5,1 mmol/l. Pas de plainte algique. Neurologique : score de Glasgow 12 (Y3M6V3), propos incohérents par moments avec alternance de moments de lucidité. Pupilles intermédiaires réactives et symétriques. Bouge les 4 membres. Paires crâniennes normales. Nuque souple. ROT perçus aux 4 membres. Cardiovasculaire : ECG avec rythme sinusal régulier, QRS fins, pas de trouble de conduction, QTc 340 ms, axe normal, aspect rSr' en V1 V2, pas de trouble de la repolarisation, crochetage en V2 connu et superposable aux autres ECG. Bruits du coeur réguliers sans souffle audible. Pas de signes d'insuffisance cardiaque. Pouls périphériques perçus. Mollets souples indolores. Respiratoire : murmure vésiculaire bilatéral symétrique, bonne ampliation thoracique, pas de bruit surajouté. Digestif : abdomen souple indolore, pas de masse palpée, bruits hydro-aériques perçus.

Evolution

12:18 : gaz du sang artériel : pH 7,39, pCO₂ 45, pO₂ 96, bicarbonates 27, lactates 0,4, pas de troubles ioniques, pas d'insuffisance rénale. 12:19 : TDM crâne sans injection : pas d'hyperdensité spontanée évoquant un saignement intracrânien récent, pas d'anomalie de densité du parenchyme cérébral, citernes de la base libres, structures médianes en place, pas d'hydrocéphalie, petite image spontanément dense en projection du pédoncule cérébelleux moyen droit semblant correspondre à une petite calcification des plexus, aération physiologique des sinus de la face et cellules mastoïdiennes, pas d'anomalie d'allure traumatique récente sur la fenêtre osseuse. 12:19 : toxiques urinaires en attente ; éthanolémie négative ; CPK négatifs ; pas de syndrome inflammatoire ; pas d'insuffisance rénale ; pas de troubles ioniques. 13:44 : fluctuation de la conscience aux urgences, passant de somnolent stimuable à la douleur à Glasgow 15. 16:50 : discussion avec la mère : elle dit n'avoir jamais observé ce type de malaise dans l'enfance ni actuellement ; accord pour que son numéro soit noté dans le dossier ; elle indique que le patient serait parti de la maison à l'âge de 17 ans pour vivre chez son père, mais qu'actuellement il n'a plus de contact avec lui ; elle rapporte avoir évoqué une origine psychogène avec le patient, ce qui l'aurait énervé.

Examens complémentaires

Biologie : éthanolémie, hémogramme-plaquettes, gaz du sang artériel, CRP, créatine kinase, troponine Ic ultrasensible, D-dimères, toxicologie urinaire avec benzodiazépines, cannabis, amphétamines, opiacés, ecstasy, cocaïne, buprénorphine, méthadone. Imagerie : scanner crânioencéphalique, TDM crâne sans injection. Autres : ECG.

ECG : rythme sinusal régulier, QRS fins, pas de troubles de conduction, QTc 340 ms, axe normal, aspect rSr' en V1 V2, pas de troubles de la repolarisation ; crochetage en V2 connu, superposable aux autres ECG. TDM crâne sans injection du 22/07/2025 à 12:19 : pas d'hyperdensité spontanée évoquant un saignement intracrânien récent. Pas d'anomalie de densité du parenchyme cérébral. Cisternes de la base libres. Structures médianes en place. Pas d'hydrocéphalie. Petite image spontanément dense en projection du pédoncule cérébelleux moyen droit semblant correspondre à une petite calcification des plexus. Aération physiologique des sinus de la face et cellules mastoïdiennes. Pas d'anomalie d'allure traumatique récente sur la fenêtre osseuse. Conclusion : pas de saignement intracrânien récent. Gaz du sang artériel : température patient 37,0°C ; pH 7,39 ; pCO₂ 45,0 mmHg ; pO₂ 96 mmHg ; bicarbonate 27,1 mmol/l ; saturation O₂ 98,0 % ; hémoglobine totale 12,9 g/dl ; HbO₂ 96,0 % ; carboxyhémoglobine 1,1 % ; méthémoglobine 0,9 % ; lactate 0,4 mmol/l ; glucose 5,2 mmol/l ; sodium 142 mmol/l ; potassium 3,8 mmol/l ; urée 3,0 mmol/l ; créatinine 62 μmol/l ; calcium ionisé 1,24 mmol/l ; calcium ionisé corrigé pH 7,4 à 1,23 mmol/l. Biologie sanguine : CRP <5,0 mg/l ; CK 93 U/l ; troponine Ic ultrasensible 3,0 ng/l ; D-dimères 175 ng/ml ; éthanol <0,1 g/l. Hémogramme : leucocytes 7,48 x10⁹/l ; hématies 6,08 x10¹²/l ; hémoglobine 12,9 g/dl ; hématocrite 40,2 % ; VGM 66,1 fl ; TCMH 21,2 pg ; CCMH 32,1 g/dl ; IDR 15 % ; plaquettes 271 x10⁹/l ; VMP 11,4 fl ; IDP 14,7 % ; polynucléaires neutrophiles 57,1 % soit 4,27 x10⁹/l ; polynucléaires éosinophiles 2,3 % soit 0,17 x10⁹/l ; polynucléaires basophiles 0,7 % soit 0,05 x10⁹/l ; lymphocytes 30,1 % soit 2,25 x10⁹/l ; monocytes 9,8 % soit 0,73 x10⁹/l. Toxicologie urinaire : benzodiazépines négatives, amphétamines négatives, MDMA négative, cocaïne négative, THC négatif, opiacés négatifs ; buprénorphine et méthadone recherchées. Synthèse biologique notée dans le dossier : toxiques urinaires négatifs, biologie rassurante, pas de syndrome inflammatoire, pas d'insuffisance rénale, pas de troubles ioniques, CPK négatifs, éthanolémie négative.

Conclusion

Malaise avec coma transitoire retrouvé sur la voie publique, avec retour spontané de la conscience. Examen clinique, ECG, biologie, toxicologie urinaire et TDM crânienne non contributifs. Aucune cause médicale cardiaque ou neurologique retrouvée à ce stade. Suivi psychologique souhaitable. Le patient prévoit de contacter le centre des maladies rares à Pitié-Salpêtrière.

Le document a été remis au patient lors de sa sortie

JOELLE KHOURY

Pour assurer votre prise en charge, l'AP-HP s'engage à collecter vos données personnelles (ex. : nom, prénom, antécédents médicaux) dans des outils numériques hautement sécurisés et conformément à la réglementation applicable.

Pour optimiser leur activité, certains services sont susceptibles d'utiliser des outils d'intelligence artificielle, avec une validation humaine.

Par ailleurs, certaines de vos données sont pseudonymisées (c'est-à-dire privées de toutes informations directement identifiantes) et rassemblées dans un entrepôt de données de santé (EDS), afin d'être réutilisées pour produire des indicateurs de pilotage de l'activité hospitalière, ou pour faire progresser la recherche sous réserve de l'avis du comité scientifique et éthique de l'EDS.

Pour information : retrouvez vos documents AP-HP sur le carnet de santé national Mon espace santé <https://monespacesante.fr>, ainsi que sur l'espace documentaire de votre Espace patient AP-HP <https://mon.aphp.fr>.

Pour plus d'informations sur le traitement de vos données personnelles et exercer vos droits, notamment d'opposition, rendez-vous sur <https://www.aphp.fr/RGPD>.